Cirurgia

Abdome Agudo Hemorrágico

CONCEITO

Dor abdominal aguda, não traumática, com a presença de hemoperitônio.

DOR ABDOMINAL AGUDA
+
CHOQUE HIPOVOLÊMICO
=
ABDOME AGUDO HEMORRÁGICO

TRATAMENTO

- Tratamento do choque
- Controle da hemorragia - geralmente cirúrgico por LAPAROTOMIA

ATENÇÃO!
Laparoscopia está contraindicada na presença de instabilidade hemodinâmica.

QUADRO CLÍNICO E EXAME FÍSICO

Dor abdominal aguda e intensa	Sinais de CHOQUE HIPOVOLÊMICO
Sinal de Lafond	Sinal de Kehr

Peritonite nem sempre está presente!

PRINCIPAIS CAUSAS

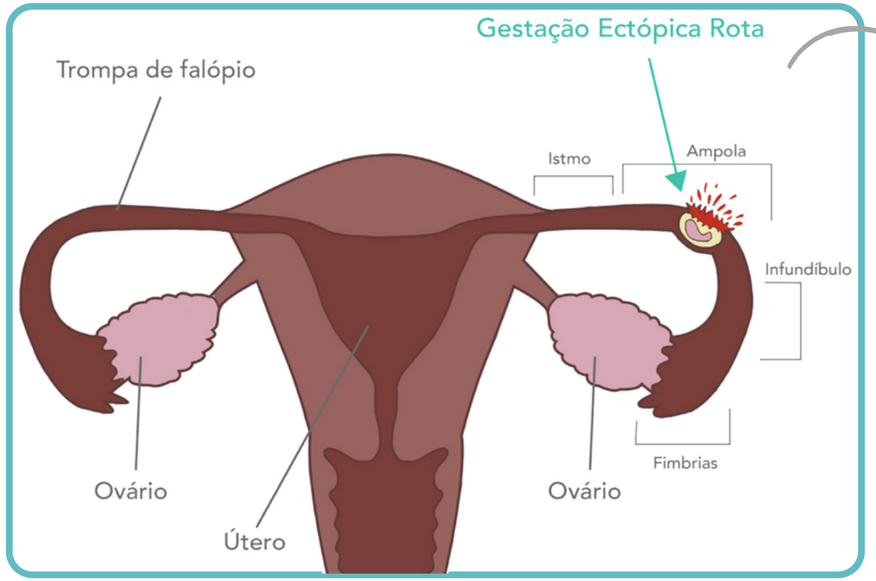
- Gravidez ectópica rota (causa mais comum)
- Cisto ovariano roto
- Ruptura de aneurisma de aorta abdominal (AAA)

Veremos a seguir

- Ruptura de aneurisma de artéria esplênica (aneurisma visceral mais comum)
- Ruptura esplênica e hepática espontânea
- Adenoma hepático roto (tumor hepático que mais se rompe - mulher jovem em uso de ACO)
- Discrasias sanguíneas

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Gravidez Ectópica Rota



Maioria dos casos de gravidez ectópica ocorre na tuba uterina (96%)

- Região mais comum de gestação ectópica: ampola
- Região onde rotura é mais frequente: istmo

Principal causa de Abdome Agudo Hemorrágico!

FATORES DE RISCO

- História de doença inflamatória pélvica
- Gravidez tubária anterior
- Cirurgia tubária anterior
- História de endometriose
- Dispositivo intrauterino permanente (DIU)
- Tabagismo

TRATAMENTO

Cirurgia de emergência: Salpingectomia

DIAGNÓSTICO

Quadro clínico

BHCG sempre positivo!

Ultrassonografia:

- Líquido livre na cavidade (hemoperitônio)
- Ausência de gestação intrauterina
- Massa extrauterina complexa (saco gestacional), geralmente na tuba uterina

QUADRO CLÍNICO

Mulher em idade reprodutiva:

Dor abdominal súbita	Sangramento vaginal anormal	Amenorreia
Sinais de choque	Sinal de Lafond	Sinal de Cullen

"Sinal de Proust" ou "Grito de Douglas"

Estratégia MED
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Diagnóstico diferencial da Gravidez Ectópica Rota!

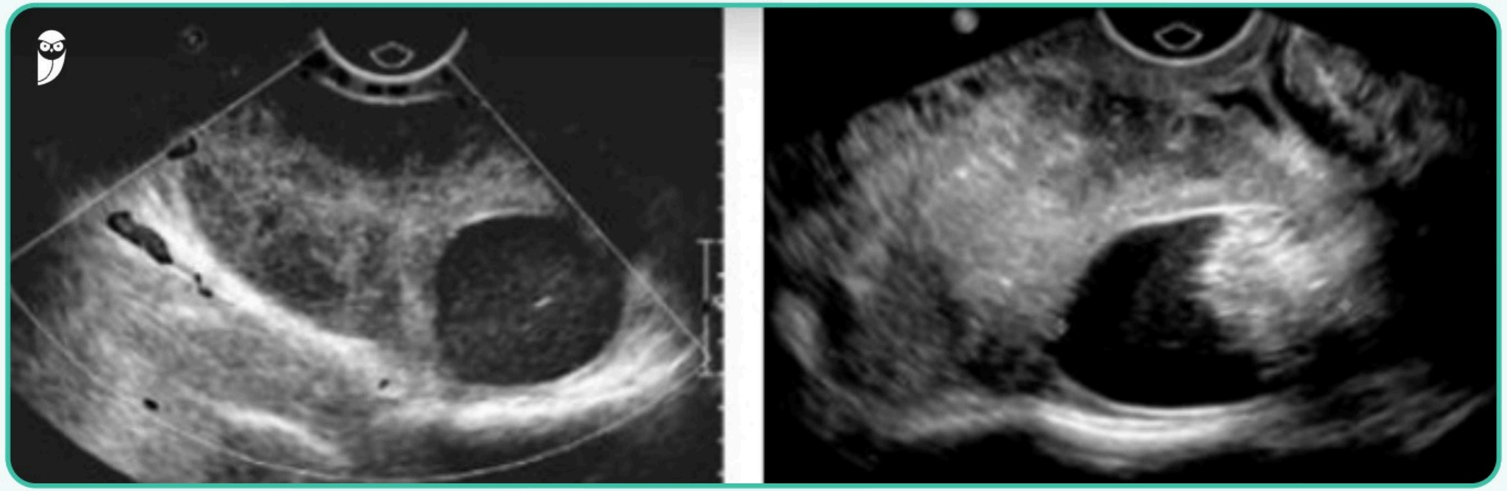
Cisto Ovariano Roto

QUADRO CLÍNICO

- ✓ Mulher em idade fértil
- ✓ Dor abdominal súbita, intensa, unilateral, geralmente após relação sexual

DIAGNÓSTICO

- Descartar ectópica rota: BHCG negativo
- USG: massa anexial e líquido livre



Cisto de ovário. Fonte: prova de acesso direto IAMSPE 2017.

TRATAMENTO

Estável	Observação
Instável	Tratamento cirúrgico (cistectomia ou ooforectomia)



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Aneurisma de Aorta Abdominal Roto

Estratégia MED

Principal complicação do AAA	Infrarrenal é o mais comum	Risco diretamente proporcional ao diâmetro do aneurisma

QUADRO CLÍNICO

TRÍADE CLÁSSICA:
- Dor abdominal e/ou lombar intensa.
- Hipotensão.
- Massa abdominal pulsátil.

EXAME FÍSICO:
- Sinal de Grey-Turner - equimose em flancos (hemorragia retroperitoneal)

Também presente na pancreatite

FATORES DE RISCO

- Diâmetro do aneurisma superior a 5,5 cm
- Aneurisma sacular
- Crescimento > 0,5 cm em 6 meses ou > 1 cm em um ano
- Aneurismas sintomáticos
- Tabagismo
- Sexo feminino
- DPOC, transplantado cardíaco ou renal

CONDUTA

SUSPEITA DE ROTURA DE AAA
Dor abdominal/lombar
Hipotensão
Massa abdominal pulsátil
Equimose em flancos

Adotar a hipotensão permissiva em pacientes sem sinais de hipoperfusão cerebral.

Paciente estável
→ ANGIOTOMOGRAFIA
→ AAA roto confirmado
→ Reparo do aneurisma: aberto ou endovascular (se disponível e anatomia favorável)

Paciente instável

Diagnóstico prévio de AAA → Reparo do aneurisma: aberto ou endovascular* (se prontamente disponível e anatomia favorável) *antes do reparo, passar balão aórtico (REBOA) para estabilizar o paciente.

Sem diagnóstico prévio de AAA
→ USG abdominal à beira do leito* *Não é obrigatório
→ AAA roto confirmado
→ Reparo do aneurisma: aberto ou endovascular* (se prontamente disponível e anatomia favorável) *antes do reparo, passar balão aórtico (REBOA) para estabilizar o paciente.

Colite isquêmica: uma das principais complicações do tratamento do AAA roto

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina